GLAVNI MATERIJAL

120 predložaka gotovih opisa

120 predložaka opisa za RTG, CT, MR i UZV/dopler. Polja Tehnika, Usporedba, Nalaz i Zaključak su spremna; Vi popunjavate samo uglate zagrade. Cilj: opis koji Vaš mentor / specijalist radiolog ne mora pisati ispočetka.

Sadržaj

Kako koristiti predloške

Poglavlje 1 · RTG (rendgenska snimka) — 30 predložaka

Poglavlje 2 · CT — 35 predložaka

Poglavlje 3 · MR — 25 predložaka

Poglavlje 4 · UZV i dopler — 30 predložaka

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti predloške

Svaki predložak je pisani oblik metode u 4 koraka: PRIPREMITE · PREGLEDAJTE · OPIŠITE · SAŽMITE.

> *Predložak ne zamjenjuje razmišljanje; omogućuje Vam da ono što mislite napišete potpuno i redoslijedom koji Vaš mentor očekuje.*

POLJE PREDLOŠKA	KORAK U METODI	ŠTO PIŠETE
Tehnika	PRIPREMITE	Pretraga, projekcija ili sekvencije, kontrast i faza, tehnička zadovoljavajućost. Ako je nezadovoljavajuća, jasno to navedite.
Usporedba	OPIŠITE · Usporedite	Datum i modalitet prethodne pretrage; ako je nema, «nema prethodne pretrage za usporedbu».
Nalazi	PREGLEDAJTE + OPIŠITE	Svako područje svaki put istim redoslijedom; pravi pojam (denzitet / signal / ehogenost), lokalizacija, veličina, ograničenje. Navedite i važne negativne nalaze.
Zaključak	SAŽMITE	Odgovor na kliničko pitanje, najvažniji nalaz na prvom mjestu, po potrebi diferencijalna dijagnoza i preporuka. Ako postoji hitni nalaz, kome je i u koliko sati javljen.

Uglate zagrade

U predlošcima **[desno/lijevo]**, **[.. mm]**, **[datum]**, **[vrijeme]** i slična polja specifična su za pacijenta. Opcije su navedene s kosom crtom: ostavite odgovarajuću, ostale izbrišite. Prije potpisivanja opisa u tekstu ne smije ostati nijedna uglata zagrada.

1. **Odaberite pravi predložak** — ovisno o pretrazi i glavnom nalazu. Kod normalne pretrage započnite predloškom «Normalan nalaz».
2. **Popunite polja Tehnika i Usporedba** — upišite datum prethodne pretrage samo ako ste je stvarno otvorili.
3. **Prilagodite nalaz vlastitom sustavnom pregledu** — dodajte nalaz koji nije u predlošku, izbrišite nalaz koji niste vidjeli.
4. **Zaključak napišite prema kliničkom pitanju** — možete upotrijebiti odgovarajuću rečenicu iz Banke od 200 zaključaka opisa.

5 **Primijenite kontrolni popis opisa na jednoj stranici** — zatim potpišite ili pošaljite Vašem mentoru.

Zamka kopiranja i lijepljenja

Pogreške u strani, mjerama i datumima najčešće nastaju iz teksta preostalog iz predloška. Svaku rečenicu u predlošku pojedinačno provjerite prema slici koju vidite; ne ostavljajte ništa što ne vidite samo zato što «stoji u predlošku».

Praksa Vaše ustanove ima prednost

Ako se format opisa, klasifikacijski sustavi i pojmovi koje koristi Vaš odjel razlikuju od ovih predložaka, uvijek primijenite format svojeg odjela. Predloške prilagodite u skladu s tim.

POGLAVLJE 1

RTG (rendgenska snimka)

30 predložaka: 4 normalna, 26 čestih nalaza na dežurstvu i u rutini.

001 PA RTG prsnog koša · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: RTG snimke prsnog koša odraslih kod boli u prsima, kašlja ili prijeoperacijske procjene na kojima niste utvrdili patologiju.

Tehnika: RTG prsnog koša u stojećem PA položaju. Inspirij i penetracija su zadovoljavajući, bez izraženije rotacije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Traheja je u središnjoj liniji. Veličina srca je unutar normalnih granica. Medijastinum i hilusne strukture urednog su izgleda. U parenhimu obaju pluća nisu utvrđeni konsolidacija, masa ni nodul. Kostofrenični kutovi su slobodni. Nije prikazan pneumotoraks. Kupole ošita su glatkih kontura. U prikazanim koštanim strukturama nema izražene patologije.

Zaključak: Na RTG snimci prsnog koša nije utvrđena akutna kardiopulmonalna patologija.

002 Nativna snimka abdomena u stojećem položaju · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Snimke na kojima kod boli u trbuhu, kao odgovor na pitanje o opstrukciji ili slobodnom zraku, ne vidite patologiju.

Tehnika: Nativna snimka abdomena u stojećem položaju; kupole ošita u vidnom polju.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Ispod ošita nije prikazan slobodni zrak. Nisu prikazane dilatirane vijuge crijeva s razinama zrak-tekućina. U kolonu i rektumu prikazuje se plin. Nema jasno vidljivih rendgenski vidljivih kamenaca. Sjene psoasa su vidljive. Prikazane koštane strukture su uredne.

Zaključak: Na nativnoj snimci abdomena nisu utvrđeni nalazi u prilog opstrukcije ili slobodnog zraka.

003 RTG ručnog zgloba · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: RTG snimke ručnog zgloba nakon pada ili uganuća na kojima ne vidite frakturu ni luksaciju.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG ručnog zgloba u AP i lateralnoj projekciji.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U distalnom radijusu, ulni i karpalnim kostima nije prikazana akutna linija frakture. Radiokarpalni i interkarpalni zglobni prostori su očuvani, poravnanje je normalno. Nema izražene otekline mekih tkiva.

Zaključak: [Desno/Lijevo] u ručnom zglobu nije utvrđena akutna koštana patologija. Ako se klinički sumnja na prijelom skafoida, okultni prijelom ne može se isključiti RTG snimkom; preporučuje se kliničko praćenje i po potrebi dodatna obrada.

004 RTG koljena · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Slučajevi ozljede ili boli koljena u kojima ne vidite koštanu patologiju.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG koljena u AP i lateralnoj projekciji.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Nije prikazana fraktura ni luksacija. Tibiofemoralni i patelofemoralni zglobni prostori su očuvani. U suprapatelarnom području nema znakova značajnog izljeva. Mineralizacija kostiju je uredna.

Zaključak: [Desno/Lijevo] na RTG snimci koljena nije utvrđena akutna koštana patologija.

005 PA RTG prsnog koša · Pneumotoraks

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u prsima, dispneje, nakon traume ili intervencije vidite pleuralnu liniju. Može zahtijevati prijavu.

Tehnika: RTG prsnog koša u stojećem PA položaju.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u hemitoraksu prisutan je pneumotoraks bez plućne vaskularne crteže lateralno od pleuralne linije; u razini apeksa razmak između pleuralne linije i stijenke prsnog koša [.. mm]. Pomak medijastinuma [nije prikazan/prema suprotnoj strani]. Fraktura rebra [nije prikazan/na ... rebru].

Zaključak: [Desno/Lijevo] pneumotoraks. Radiološki nalazi u prilog tenzijskog [nema/ima]. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

006 RTG prsnog koša · Znakovi tenzijskog pneumotoraksa

Kada se koristi: Slučajevi opsežnog pneumotoraksa s potiskivanjem medijastinuma. Tenzijski pneumotoraks je klinička dijagnoza; možda je liječen prije snimanja.

Tehnika: [PA/AP u krevetu] RTG prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u hemitoraksu velik pneumotoraks; ipsilateralno plućno krilo kolabirano je prema hilusu. Medijastinum i traheja potisnuti su na suprotnu stranu, ipsilateralna hemidijafragma je spljoštena, interkostalni prostori su prošireni.

Zaključak: [Desno/Lijevo] radiološki nalazi u prilog velikog pneumotoraksa i tenzijskog pneumotoraksa. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme] telefonski javljeno.

007 PA RTG prsnog koša · Pleuralni izljev

Kada se koristi: Slučajevi s tupim kostofreničnim kutom ili meniskoidnim izgledom.

Tehnika: Stojeći PA [± lateralna] RTG prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo/Obostrano] zatupljenje kostofreničnog sinusa i zasjenjenje konkavne gornje granice u obliku meniskusa; [mala/umjerena/velika] količina pleuralnog izljeva (odgovara nalazu). Podležeću konsolidaciju u susjednom plućnom parenhimu nije moguće razlučiti. Medijastinum [uobičajen/potisnut na suprotnu stranu].

Zaključak: [Desno/Lijevo/Obostrano] [mala/umjerena/velika] količina pleuralnog izljeva. Podležeća parenhimska patologija ne može se isključiti na snimci; preporučuje se korelacija s kliničkim nalazom i po potrebi UZV-om.

008 PA RTG prsnog koša · Lobarna konsolidacija

Kada se koristi: Slučajevi s vrućicom, kašljem i zasjenjenjem sa zračnim bronhogramom.

Tehnika: Stojeći PA [± lateralna] RTG prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [gornji/srednji/donji] režnju: područje homogene konsolidacije sa zračnim bronhogramom. Volumen režnja je očuvan. [Bez pratećeg pleuralnog izljeva/mala količina pleuralnog izljeva].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [režanj] konsolidacija; u kontekstu kliničke slike može odgovarati pneumoniji. Radiološka kontrola nakon terapije preporučuje se prema kliničkoj odluci.

009 PA RTG prsnog koša · Atelektaza

Kada se koristi: Slučajevi u kojima vidite zasjenjenje uz znakove gubitka volumena.

Tehnika: Stojeći PA [± lateralna] RTG prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [režanj]: zasjenjenje s gubitkom volumena; u fisuri [pomak], u ipsilateralnom hilusu [gore/dolje] povlačenje i elevacija hemidijafragme.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [režanj] nalazi koji odgovaraju atelektazi. Radi isključenja centralnog opstruktivnog uzroka preporučuje se klinička korelacija i po potrebi CT prsnog koša.

010 RTG prsnog koša · Kardiomegalija

Kada se koristi: Slučajevi u kojima se na PA snimci sjena srca čini povećanom. Na AP snimci veličina srca može zavarati; navedite to u opisu.

Tehnika: [PA/AP] RTG prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Kardiotorakalni indeks je povećan. Plućne krvne žile [uobičajen/naglašen]. Pleuralni izljev [nije prikazan/...].

Zaključak: Kardiomegalija [Na PA snimci]. Razlikovanje od perikardijalnog izljeva nije moguće na rendgenskoj snimci; uz kliničku indikaciju preporučuje se korelacija s ehokardiografijom.

011 RTG prsnog koša · Plućni edem

Kada se koristi: Slučajevi sa sumnjom na dispneju, srčano zatajenje ili preopterećenje tekućinom.

Tehnika: [PA/AP u krevetu] RTG prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Obostrana perihilarna zasjenjenja u obliku leptirovih krila; pojačan intersticijski crtež (Kerleyjeve B-linije), peribronhalno zadebljanje i naglašenost krvnih žila gornjih polja. Obostrano [mala količina] pleuralni izljev. Veličina srca [povećan/normalan].

Zaključak: Nalazi koji upućuju na plućni edem; mogu odgovarati kardiogenom edemu. Preporučuje se klinička korelacija.

012 PA RTG prsnog koša · Plućna masa

Kada se koristi: Slučajevi u kojima vidite okruglo zasjenjenje čije se granice mogu procijeniti.

Tehnika: RTG prsnog koša u stojećem PA i lateralnom položaju.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [gornji/srednji/donji] u zoni [.. mm] veličine, [glatkih rubova/lobuliran/spikuliran] kontura, okruglo zasjenjenje. Kalcifikacija [nije prikazan]. Proširenje hilusa ili medijastinuma [nema/ima]. Pleuralni izljev [nema/ima]. Destrukcija susjednih rebara [nije prikazan].

Zaključak: [Desno/Lijevo] pluća [zona]: [.. mm] ekspanzivna lezija. Za daljnju procjenu preporučuje se CT prsnog koša s kontrastom.

013 PA RTG prsnog koša · Kavitarna lezija

Kada se koristi: Slučajevi u kojima vidite leziju sa stijenkom koja sadrži zrak.

Tehnika: Stojeći PA [± lateralna] RTG prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [gornji/srednji/donji] u zoni stijenka [tanka/debela, nepravilna] kavitarna lezija; unutar nje razina zrak-tekućina [prisutan/odsutan]. U okolini [konsolidacija/nodularna zasjenjenja].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [zona]: kavitarna lezija. U diferencijalnoj dijagnozi su infektivni procesi uključujući tuberkulozu, apsces pluća i kavitarna neoplazma; preporučuje se klinička i mikrobiološka korelacija te CT prsnog koša.

014 RTG prsnog koša · Fraktura rebra

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon traume prsnog koša vidite prekid kontinuiteta korteksa.

Tehnika: PA RTG prsnog koša [± snimka rebara].

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [..]. rebro [anteriorno/lateralno/posteriorno] u luku [bez pomaka/s pomakom] linija prijeloma. Pneumotoraks nije prikazan. Pleuralna tekućina u prilog hemotoraksa [nema/ima]. Potkožni emfizem [nema/ima].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [..]. fraktura rebra; nije prikazan pridruženi pneumotoraks. Osjetljivost rendgenske snimke za prikaz fraktura rebara je ograničena.

015 RTG prsnog koša uz krevet · Položaj endotrahealnog tubusa

Kada se koristi: Bolesnici u jedinici intenzivnog liječenja i na hitnom prijmu kod kojih se nakon intubacije traži provjera položaja vrha tubusa.

Tehnika: AP RTG prsnog koša uz krevet.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Vrh endotrahealnog tubusa nalazi se od karine [.. cm] iznad, prikazuje se u središnjoj liniji traheje. [Vrh nazogastrične sonde projicira se u želudac.] Nije prikazan pneumotoraks. [Nema novonastalog zasjenjenja.]

Zaključak: Vrh endotrahealnog tubusa, u odnosu na karinu, [.. cm] iznad [u odgovarajućem položaju]. / Vrh cijevi [desni glavni bronh] u projekciji; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

016 RTG prsnog koša uz krevet · Centralni venski kateter

Kada se koristi: Kontrola položaja vrha i pneumotoraksa nakon postavljanja CVK.

Tehnika: AP RTG prsnog koša uz krevet.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [unutarnja jugularna/potklučna] vena kao pristup, vrh centralnog venskog katetera [gornja šuplja vena/kavoatrijski spoj] u projekciji. Pneumotoraks nije prikazan. Nema novog proširenja medijastinuma.

Zaključak: Vrh CVK [gornja šuplja vena] u projekciji. Pneumotoraks vezan uz zahvat nije prikazan.

017 RTG prsnog koša · Položaj nazogastrične sonde

Kada se koristi: Slučajevi u kojima se prije početka hranjenja traži provjera položaja vrha NG sonde.

Tehnika: AP snimka prsnog koša i gornjeg abdomena uz krevet.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Nazogastrična sonda prolazi središnjom linijom duž toka jednjaka, prelazi ošit, a vrh joj se prikazuje u lijevom gornjem kvadrantu u projekciji želuca.

Zaključak: Vrh nazogastrične sonde u projekciji želuca. / Vrh sonde [desni glavni bronh/jednjak] u projekciji, nije u odgovarajućem položaju; prije korištenja kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

018 Snimka u stojećem položaju · Pneumoperitoneum

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod akutnog abdomena vidite slobodni zrak ispod ošita. Zahtijeva hitnu prijavu.

Tehnika: RTG prsnog koša u stojećem položaju / nativna snimka abdomena u stojećem položaju.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Obostrano] ispod kupole ošita prikazuje se radiolucentno područje koje odgovara slobodnom zraku.

Zaključak: Pneumoperitoneum (slobodni zrak). Ako nema podatka o nedavnom kirurškom zahvatu ili intervenciji, preporučuje se hitna klinička procjena radi perforacije šupljeg organa. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

019 Nativna snimka abdomena u stojećem položaju · Opstrukcija tankog crijeva

Kada se koristi: Slučajevi koji dolaze s povraćanjem, distenzijom i izostankom vjetrova i stolice.

Tehnika: Nativna snimka abdomena u stojećem položaju [± u ležećem položaju].

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Centralno smještene dilatirane vijuge tankog crijeva s vidljivim valvulae conniventes i razinama zrak-tekućina na različitim visinama. Plin u kolonu [smanjen/nije prikazan]. Ispod ošita nema slobodnog zraka.

Zaključak: Nalazi koji odgovaraju opstrukciji tankog crijeva. Za procjenu razine, uzroka i komplikacija preporučuje se CT abdomena s kontrastom.

020 Nativna snimka abdomena · Sumnja na volvulus sigme

Kada se koristi: Slučajevi s izraženom distenzijom, osobito kod starijih bolesnika, u kojima vidite golemu vijugu kolona.

Tehnika: U stojećem položaju [± u ležećem položaju] nativni RTG abdomena.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Izrazito dilatirana vijuga kolona u obliku obrnutog slova U, bez haustracija, koja se pruža od zdjelice prema gornjem kvadrantu (izgled zrna kave).

Zaključak: Nalazi koji upućuju na volvulus sigme. Preporučuje se hitna klinička procjena; za potvrdu i procjenu komplikacija može se razmotriti CT. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

021 Nativna snimka mokraćnog sustava · Rendgenski vidljiv kamenac

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u slabini vidite zasjenjenje u projekciji bubrega ili duž toka uretera.

Tehnika: Nativna snimka mokraćnog sustava.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [bubreg/tijek uretera/zdjelica] u projekciji [.. mm] velik opakni denzitet.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [lokalizacija] u projekciji denzitet koji može odgovarati opaknom konkrementu. Za razlikovanje od flebolita i procjenu opstrukcije preporučuje se korelacija s UZV-om ili nativnim CT-om.

022 RTG ručnog zgloba · Fraktura distalnog radijusa

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon pada na šaku vidite liniju frakture u distalnom radijusu.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG ručnog zgloba u AP i lateralnoj projekciji.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u metafizi distalnog radijusa, do zglobne plohe [koji se proteže/koji se ne proteže], [dorzalno/volarno] linija prijeloma s angulacijom. Prijelom stiloidnog nastavka ulne [prati/ne prati]. Skraćenje radijusa [prisutan/odsutan].

Zaključak: [Desno/Lijevo] prijelom distalnog radijusa ([intraartikularni/ekstraartikularni], [dorzalno/volarno] s angulacijom).

023 RTG ručnog zgloba · Fraktura skafoida

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod bolesnika s osjetljivošću anatomske tabakere vidite liniju frakture skafoida.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG ručnog zgloba u AP, lateralnoj i skafoidnoj projekciji.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Skafoid [struk/proksimalni pol/distalni pol] na toj razini [tanak/dislociran] linija prijeloma. Skafoidna masna linija [obrisan/očuvan].

Zaključak: [Desno/Lijevo] skafoid [slabinski] prijelom. Kod prijeloma proksimalnog pola preporučuje se ortopedsko praćenje zbog rizika od avaskularne nekroze.

024 RTG kuka · Fraktura vrata femura

Kada se koristi: Bolesnici, osobito stariji, koji nakon pada dolaze s boli u kuku i nemogućnošću hoda.

Tehnika: AP zdjelice i [desno/lijevo] lateralne snimke kuka.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u vratu femura [subkapitalni/transcervikalni/bazocervikalni] linija prijeloma; [s pomakom/bez pomaka, impaktirana]. Zglob kuka [odgovara].

Zaključak: [Desno/Lijevo] prijelom vrata femura ([s pomakom/bez pomaka]). Ako je rendgenska snimka negativna, a klinička sumnja visoka, zbog moguće okultne frakture preporučuje se MR ili CT.

025 RTG ramena · Glenohumeralna luksacija

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon traume ramena glava humerusa nije sukladna s glenoidom.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG ramena u AP i [skapularna Y/aksilarna] snimke.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] glava humerusa [anteroinferiorno/posteriorno] u odnosu na glenoid; poremećena je kongruencija glenohumeralnog zgloba. Prijelom velike kvržice [nema/ima]. [Hill-Sachs/Bankart] koštane promjene u prilog tome [nije prikazan/prikazan je].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [anteriorno/posteriorno] glenohumeralna luksacija. Preporučuje se kontrolna snimka nakon repozicije.

026 RTG gležnja · Fraktura maleola

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon uganuća vidite liniju frakture na maleolima.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG gležnja u AP, mortise i lateralnoj projekciji.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [lateralni maleol/distalna fibula] u razini, sindezmoze [ispod/u razini/iznad] [kosa/poprečna] linija prijeloma. Prijelom medijalnog maleola [prisutan/odsutan]. Prostor maleolarne vilice [simetričan/medijalno proširen]. Oteklina mekih tkiva.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [lateralni maleol] prijelom; maleolarna vilica [očuvan/proširen].

027 RTG potkoljenice · Fraktura dijafize tibije

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon visokoenergetske traume vidite frakturu dijafize tibije.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG potkoljenice u AP i lateralnoj projekciji (uključujući koljeno i gležanj).

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] tibija [proksimalno/srednje/distalno] trećini dijafize [poprečna/kosa/spiralna/kominutivna] prijelom; [.. mm] pomak i [anteriorno/posteriorno] angulacija. Fibula [intaktan/prelomljen]. Zrak u mekim tkivima [nema/ima].

Zaključak: [Desno/Lijevo] prijelom dijafize tibije ([tip prijeloma]); fibula [intaktan/prelomljen]. Ako postoji zrak u mekim tkivima, preporučuje se klinička korelacija radi moguće otvorene frakture.

028 RTG koljena · Osteoartritis

Kada se koristi: Bolesnici s kroničnom boli u koljenu bez akutne traume.

Tehnika: [Desno/Lijevo] koljeno [u stojećem položaju] AP i lateralne snimke.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u koljenu [medijalno/lateralno] suženje tibiofemoralnog zglobnog prostora, rubni osteofiti i subhondralna skleroza. Akutni prijelom nije prikazan.

Zaključak: [Desno/Lijevo] u koljenu [izraženo u medijalnom odjeljku] degenerativne promjene (osteoartritis). Akutna koštana patologija nije utvrđena.

029 RTG lakta (dijete) · Suprakondilarna fraktura humerusa

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod djece s boli u laktu nakon pada vidite znak masnog jastučića ili liniju frakture.

Tehnika: [Desno/Lijevo] RTG lakta u AP i lateralnoj projekciji.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Na lateralnoj snimci prednji masni jastučić je podignut, a stražnji masni jastučić je vidljiv. Prednja humeralna linija kapitelum [ne prolazi kroz srednju trećinu]. U suprakondilarnom području [tanak/dislociran] linija prijeloma [prikazuje se/nije jasno razlučiv].

Zaključak: [Desno/Lijevo] suprakondilarni prijelom humerusa ([s pomakom/bez pomaka]). Iako linija frakture nije vidljiva, znak stražnjeg masnog jastučića upućuje na okultnu frakturu; preporučuje se ortopedska procjena.

030 RTG · Progutano rendgenski vidljivo strano tijelo

Kada se koristi: Bolesnici, osobito djeca, koji dolaze s anamnezom gutanja stranog tijela.

Tehnika: AP snimka koja obuhvaća vrat, prsni koš i abdomen [± lateralna] snimka.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Gornji/srednji/distalni dio jednjaka/želudac/tanko crijevo] u projekciji [.. mm] velik radioopakni strani predmet. Izgled dvostrukog prstena / dvostruke konture [prisutan/odsutan]. Nije prikazan slobodni zrak.

Zaključak: [Lokalizacija] u projekciji radioopakni strani predmet. Smještaj u jednjaku ili sumnja na dugmastu bateriju smatraju se hitnim stanjem; kliničkom timu [vrijeme] javljeno. Radiolucentna strana tijela ne moraju biti vidljiva na rendgenskoj snimci.

POGLAVLJE 2

CT

35 predložaka: 4 normalna, 31 čest nalaz na dežurstvu i u rutini.

031 CT mozga bez kontrasta · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod glavobolje, sinkope ili lakše ozljede glave ne vidite patologiju.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta; aksijalni presjeci procijenjeni su u moždanom i koštanom prozoru.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Intrakranijalno krvarenje, učinak mase ni pomak središnje linije nisu prikazani. Granica sive i bijele tvari je očuvana. Klijetke i sulkusi primjerene su širine za dob. Bazalne cisterne su prohodne. Prijelom kalvarija nije prikazan. Prikazani paranazalni sinusi i mastoidne stanice su prozračni.

Zaključak: Na CT-u mozga bez kontrasta nije utvrđena akutna intrakranijska patologija. Rani ishemijski moždani udar ne mora biti vidljiv na CT-u bez kontrasta; ako klinička sumnja i dalje postoji, može se razmotriti MR-DWI.

032 CT vratne kralježnice (trauma) · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon traume, kod pitanja o ozljedi vratne kralježnice, ne vidite patologiju.

Tehnika: CT vratne kralježnice bez kontrasta; sagitalne i koronalne rekonstrukcije, koštani i mekotkivni prozor.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Poravnanje vratnih kralježaka je očuvano. Nije prikazana akutna fraktura ni luksacija. Fasetni zglobovi su sukladni. Kraniocervikalni prijelaz je uredan. Debljina prevertebralnih mekih tkiva je uredna.

Zaključak: Na CT-u vratne kralježnice nije utvrđena akutna traumatska koštana patologija. Ligamentarna ozljeda ne može se CT-om potpuno isključiti; u slučaju neurološkog nalaza preporučuje se MR.

033 CT prsnog koša · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: CT pretrage prsnog koša kod rutinskih ili neonkoloških indikacija na kojima ne vidite patologiju.

Tehnika: [S IV kontrastom/Bez kontrasta] CT prsnog koša; procijenjeno u medijastinalnom i plućnom prozoru.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U medijastinumu nisu prikazani limfni čvorovi patološke veličine. Veličina srca je normalna, nema perikardijalnog izljeva. Glavne krvne žile su urednog promjera. U plućnom parenhimu nisu utvrđeni konsolidacija, masa ni značajan nodul. Nema pleuralnog izljeva ni pneumotoraksa. U prikazanom gornjem abdomenu i koštanim strukturama nije prikazana patologija.

Zaključak: Na CT-u prsnog koša nije utvrđena značajna patologija.

034 CT abdomena i zdjelice · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: CT pretrage abdomena i zdjelice s kontrastom kod boli u trbuhu na kojima ne vidite akutnu patologiju.

Tehnika: CT abdomena i zdjelice s i.v. kontrastom, portalna venska faza. Peroralni kontrast [primijenjen je/nije primijenjen].

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Jetra, slezena, gušterača, nadbubrežne žlijezde i bubrezi normalne su veličine i denziteta; žarišne lezije nisu utvrđene. Žučnjak je uredan; intrahepatalni i ekstrahepatalni žučni vodovi nisu dilatirani. Nije prikazana dilatacija ni zadebljanje stijenke crijevnih vijuga. Apendiks [urednog izgleda/nije jasno razlučiv, bez znakova upale u donjem desnom kvadrantu]. Nema slobodne tekućine ni slobodnog zraka. Nema patološki povećanih limfnih čvorova. Mokraćni mjehur je uredan. U koštanim strukturama nisu prikazane litičke ni blastične lezije.

Zaključak: CT-om abdomena i zdjelice nije utvrđena akutna patologija.

035 CT mozga bez kontrasta · Epiduralni hematom

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon ozljede glave vidite bikonveksnu hiperdenznu kolekciju. Hitna prijava.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta; moždani i koštani prozor.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [temporalno/parijetalno/frontalno] području, ne prelazi suture, bikonveksnog (lentiformnog) oblika, na najdebljem mjestu [.. mm] izmjerena hiperdenzna ekstraaksijalna kolekcija. U susjednom kalvariju [linearna linija prijeloma]. Pomak središnje linije [.. mm]. Bazalne cisterne [slobodan/obrisan].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [regija] akutni epiduralni hematom; [.. mm] pomak središnje linije. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

036 CT mozga bez kontrasta · Subduralni hematom

Kada se koristi: Slučajevi u kojima vidite ekstraaksijalnu kolekciju u obliku polumjeseca, osobito kod starijih bolesnika i onih koji uzimaju antikoagulanse.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] uzduž konveksiteta hemisfere, prelazi suture, polumjesečastog oblika, [hiperdenzan/izodenzan/hipodenzan/miješanog denziteta] subduralna kolekcija; najdeblje mjesto [.. mm]. Izbrisanost sulkusa, kompresija ipsilateralne lateralne komore i [.. mm] pomak središnje linije.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [akutni/subakutni/kronični/akutni na kroničnom] subduralni hematom; učinak mase [prisutan/odsutan]. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

037 CT mozga bez kontrasta · Subarahnoidalno krvarenje

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod naglo nastale jake glavobolje ili nakon traume vidite hiperdenzitet u cisternama.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Bazalne cisterne/Silvijeve fisure/interhemisferna fisura/kortikalni sulkusi] unutar njih hiperdenzno subarahnoidalno krvarenje. Intraventrikularno krvarenje [nema/ima]. Proširenje ventrikula [nema/ima]. Parenhimski hematom [nema/ima].

Zaključak: [Difuzno/Fokalno] subarahnoidalno krvarenje. Hidrocefalus [nema/ima]. Ako nema podatka o traumi, radi aneurizme preporučuje se CT angiografija. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

038 CT mozga bez kontrasta · Intracerebralno krvarenje

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod bolesnika s akutnim neurološkim deficitom vidite intraparenhimski hiperdenzni hematom.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [bazalni gangliji/talamus/lobarno/cerebelarno] smještena, [.. x .. mm] velik hiperdenzni parenhimski hematom; oko njega hipodenzni edem. Prodor u klijetke [nema/ima]. Pomak središnje linije [.. mm].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [lokalizacija] akutni intraparenhimski hematom. Ovisno o kliničkom stanju preporučuje se daljnja obrada radi utvrđivanja podležećeg uzroka. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

039 CT mozga bez kontrasta · Rani znakovi ishemijskog moždanog udara

Kada se koristi: CT pretrage učinjene po protokolu za moždani udar zbog akutnog žarišnog neurološkog deficita.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta; učinjena je dodatna procjena u prozoru za moždani udar.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [U opskrbnom području MCA/u inzularnom korteksu/u lentiformnoj jezgri] brisanje granice sive i bijele tvari i blagi hipodenzitet; brisanje susjednih sulkusa. Intrakranijalno krvarenje nije prikazano.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [MCA] nalazi koji odgovaraju ranoj akutnoj ishemiji u opskrbnom području; nema intrakranijalnog krvarenja. U okviru protokola za moždani udar kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

040 CT mozga bez kontrasta · Znak hiperdenzne MCA

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod sumnje na moždani udar vidite izraziti hiperdenzitet MCA u odnosu na suprotnu stranu.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] MCA [M1/M2] segmentu izraziti hiperdenzitet u odnosu na suprotnu stranu (znak hiperdenzne arterije). Prateće rane ishemijske promjene [nema/ima]. Nije prikazano krvarenje.

Zaključak: [Desno/Lijevo] Znak hiperdenzne arterije u MCA; može upućivati na akutni tromb. Preporučuje se procjena CT angiografijom. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

041 CT mozga bez kontrasta · Hidrocefalus

Kada se koristi: Slučajevi u kojima su ventrikuli prošireni nerazmjerno sulkusima.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U lateralnim i trećoj komori [i u četvrtoj klijetki] izrazito proširenje nesrazmjerno sulkusima. Periventrikularni hipodenzitet [prisutan/odsutan]. Razina opstrukcije: [razina/nije jasno razlučivo].

Zaključak: [Opstruktivni/Komunicirajući] nalazi u prilog hidrocefalusa. U odnosu na prethodnu pretragu [povećanje/bez promjene]. Ako je nastalo akutno, kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

042 CT mozga · Tumorska masa i vazogeni edem

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod glavobolje, napadaja ili žarišnog deficita vidite leziju s učinkom mase.

Tehnika: Bez kontrasta [± s IV kontrastom] CT mozga.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [režanj]: [.. mm] veličine [izodenzan/hiperdenzan] ekspanzivna lezija; oko nje vazogeni edem s prstolikim izdancima. Učinak mase: brisanje sulkusa, [kompresija ipsilateralne klijetke], [.. mm] pomak središnje linije.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [režanj] ekspanzivna lezija i okolni vazogeni edem. Za karakterizaciju se preporučuje MR mozga s kontrastom. Znakovi hernijacije [nije prisutan/prisutan; kliničkom timu je javljeno].

043 CT mozga · Fraktura kalvarije

Kada se koristi: Slučajevi ozljede glave u kojima u koštanom prozoru vidite liniju frakture.

Tehnika: CT mozga bez kontrasta; koštani prozor i 3D rekonstrukcija.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [frontalno/parijetalno/temporalno/okcipitalno] u kosti [linearni/impresijski] linija prijeloma; stupanj impresije [.. mm]. Susjedno ekstraaksijalno krvarenje [nema/ima]. Pneumocefalus [nema/ima]. Hematom vlasišta.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [kost] [linearni/impresijski] prijelom. Prateće intrakranijalno krvarenje [nije prikazan/...].

044 CT plućna angiografija · Plućna embolija

Kada se koristi: Slučajevi u kojima na CTPA učinjenoj zbog sumnje na PE vidite defekt punjenja. Hitna prijava.

Tehnika: CT plućna angiografija. Opacifikacija plućne arterije [adekvatna/neadekvatna].

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo/Obostrano] [glavna/lobarna/segmentna/subsegmentna] defekti punjenja u plućnim arterijama. Omjer desne i lijeve klijetke [povećan/uobičajen]; u interventrikularnom septumu [izravnavanje/izbočenje ulijevo] [prisutan/odsutan]. Klinasta konsolidacija na periferiji [nije prisutan/prisutan; može odgovarati infarktu].

Zaključak: [Obostrano] akutna plućna tromboembolija. Nalazi u prilog opterećenja desne klijetke [prisutan/odsutan]. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

045 CT prsnog koša · Incidentalni plućni nodul

Kada se koristi: Slučajevi u kojima na CT-u učinjenom iz drugog razloga vidite slučajni nodul.

Tehnika: [S IV kontrastom/Bez kontrasta] CT prsnog koša, tanki slojevi.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [režanj] [segment]: [.. mm] veličine [solidni/subsolidni/mliječno staklo] nodul; [glatkih rubova/lobuliran/spikuliran] kontura. Kalcifikacija [nema/ima].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [režanj]: [.. mm] [solidna] nodul. Potrebu i interval praćenja treba odrediti zajedno s kliničkim timom prema rizičnom profilu pacijenta i važećim smjernicama koje je usvojila Vaša ustanova.

046 CT prsnog koša · Emfizem

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod pušača ili bolesnika s KOPB-om vidite područja emfizema.

Tehnika: CT prsnog koša bez kontrasta; plućni prozor.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Obostrano [s predominacijom u gornjim režnjevima] [centrilobularni/paraseptalni/panlobularni] područja emfizema. [Bule.] Nije prikazana konsolidacija ni masa.

Zaključak: [Centrilobularni] emfizem. Akutna parenhimska patologija nije prikazana.

047 CT prsnog koša · Zasjenjenja tipa mliječnog stakla

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod dispneje, vrućice ili hipoksemije vidite područja mliječnog stakla.

Tehnika: [Bez kontrasta/S IV kontrastom] CT prsnog koša; plućni prozor.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Obostrano [periferno/centralno/difuzno], [s predominacijom u donjim režnjevima] zasjenjenja tipa mliječnog stakla. Zadebljanje interlobularnih septa [prati (izgled kaldrme)/ne prati]. Pleuralni izljev [nema/ima].

Zaključak: Obostrana zasjenjenja tipa mliječnog stakla. U diferencijalnoj dijagnozi dolaze u obzir virusne i atipične infekcije, plućni edem, alveolarno krvarenje i drugi upalni procesi; preporučuje se klinička i laboratorijska korelacija.

048 CT prsnog koša · Pneumotoraks

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon traume ili intervencije na CT-u vidite zrak u pleuralnom prostoru.

Tehnika: CT prsnog koša; plućni prozor.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u hemitoraksu [anteriorno/apikalno/difuzno] smještena, na najdebljem mjestu [.. mm] pneumotoraks. Pomak medijastinuma [nema/ima]. Pneumomedijastinum [nema/ima]. Potkožni emfizem [nema/ima]. Frakture rebara [nema/ima].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [mala/umjerena/velika] pneumotoraks. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

049 CT angiografija · Disekcija aorte

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod naglo nastale boli u prsima ili leđima vidite intimalni režanj. Hitna prijava.

Tehnika: CT angiografija bez kontrasta i u arterijskoj fazi.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Od ascendentne aorte/distalno od lijeve potključne arterije] s početkom [razina] pruža se intimalni flap; prikazuju se pravi i lažni lumen. Disekcija [do ogranaka luka/do celijačnog trunkusa/SMA/renalnih arterija] širenje: [detalj]. Perikardijalni izljev [nema/ima]. Medijastinalni hematom [nema/ima].

Zaključak: [Zahvaća ascendentnu aortu (Stanford A)/ne zahvaća ascendentnu aortu (Stanford B)] disekcija aorte. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

050 CT abdomena · Aneurizma abdominalne aorte

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u trbuhu ili leđima, ili slučajno, vidite proširenje aorte.

Tehnika: [Kontrastna CT angiografija/CT abdomena u portalnovenskoj fazi].

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U infrarenalnoj abdominalnoj aorti maksimalni [.. mm] promjera [fuziformna/sakularna] aneurizmatsko proširenje; kalcifikacije stijenke i [muralni tromb]. Udaljenost od renalnih arterija [.. mm]. Periaortalni hematom ili zamućenje masnog tkiva [nije prikazan/prikazan je].

Zaključak: Infrarenalna aneurizma abdominalne aorte, maksimalni promjer [.. mm]. Nalaz koji upućuje na rupturu [nije prikazan/prikazan je]. Ako postoje znakovi rupture, kao hitni nalaz kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

051 CT abdomena · Akutni apendicitis

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u desnom donjem kvadrantu vidite upaljeni apendiks.

Tehnika: CT abdomena i zdjelice s i.v. kontrastom, portalna venska faza.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Apendiks [.. mm] promjera, zadebljane stijenke i pojačane imbibicije kontrastom; zamućenje okolnog masnog tkiva. Apendikolit [prisutan/odsutan]. Periapendikularna tekućina, apsces ili slobodni zrak [nema/ima].

Zaključak: Nalazi koji odgovaraju akutnom apendicitisu. Nalaz koji upućuje na perforaciju ili apsces [nije prikazan/prikazan je]. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

052 CT abdomena · Akutni divertikulitis

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u lijevom donjem kvadrantu vidite upalu u segmentu s divertikulima.

Tehnika: CT abdomena i zdjelice s i.v. kontrastom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Sigmoidni/Silazni] divertikuli u kolonu; [.. cm] dugom segmentu zadebljanje stijenke i zamućenje perikoličnog masnog tkiva. Perikolični slobodni zrak [nema/ima]. Apsces [ne postoji/postoji, .. mm].

Zaključak: [Sigmoidni kolon] u kolonu akutni [nekomplicirana/komplicirana] divertikulitis. Procjena kolona nakon akutne faze prepušta se kliničkoj odluci.

053 CT abdomena · Opstrukcija tankog crijeva

Kada se koristi: Slučajevi sa sumnjom na opstrukciju na snimci ili oni koji dolaze s povraćanjem i distenzijom.

Tehnika: CT abdomena i zdjelice s i.v. kontrastom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Dilatirane vijuge tankog crijeva i distalno kolabirane vijuge; prijelazna zona [donji desni kvadrant/zdjelica/...]. Mogući uzrok: [adhezija/hernija/masa/nije jasno razlučivo]. Smanjeno imbibiranje stijenke crijeva kontrastom, edem mezenterija i slobodna tekućina [nema/ima]. Pneumatoza [nema/ima].

Zaključak: [Regija]: mehanička opstrukcija tankog crijeva sa zonom prijelaza; mogući uzrok [uzrok]. Nalaz koji upućuje na ishemiju [nije prikazan/prikazan je]. Ako postoje znakovi ishemije, kao hitni nalaz kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

054 CT abdomena · Pneumoperitoneum (perforacija)

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod akutnog abdomena na CT-u vidite slobodni zrak. Hitna prijava.

Tehnika: CT abdomena i zdjelice s i.v. kontrastom; dodatna procjena u plućnom prozoru.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Ispred jetre/periportalno/u mezenteriju] slobodni zrak. Slobodna tekućina [nema/ima]. Moguće mjesto perforacije: [želudac/duodenum/kolon]; [defekt stijenke/fokalno zadebljanje stijenke/upala okoline].

Zaključak: Pneumoperitoneum; [moguća lokalizacija] u prilog perforacije. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

055 CT bez kontrasta · Kamenac uretera

Kada se koristi: CT pretrage po protokolu za kamence kod sumnje na bubrežne kolike.

Tehnika: CT abdomena i zdjelice bez kontrasta (protokol za kamence).

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] ureter [u proksimalnom/srednjem/distalnom dijelu/na ureterovezikalnom spoju] [.. mm] konkrement. U proksimalnom ureteru i kanalnom sustavu [blago/umjereno/izraženo] dilatacija; zamućenje perirenalnog masnog tkiva. U kontralateralnom bubregu [bez konkrementa/konkrement od .. mm].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [distalno] u ureteru [.. mm] kamenac i [blaga] hidroureteronefroza.

056 CT abdomena · Akutni pankreatitis

Kada se koristi: Slučajevi s kliničkom i laboratorijskom sumnjom na pankreatitis u kojima se traži procjena komplikacija.

Tehnika: CT abdomena s i.v. kontrastom, [pankreatičnu fazu i] portalnovenska faza.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Gušterača [difuzno/fokalno] edematozan; zamućenje i tekućina u peripankreatičnom masnom tkivu. Područje parenhima bez imbibicije kontrastom [nema/ima]. Kamenci u žučnjaku [prisutan/odsutan]. Slezenska i portalna vena [prohodan/sumnja na tromb].

Zaključak: Akutno [intersticijski edematozni/nekrotizirajući] znakovi pankreatitisa. Komplikacija: [nije prisutan/...].

057 CT abdomena · Brojne lezije u jetri koje upućuju na metastaze

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod onkološkog bolesnika ili prvi put vidite brojne lezije u jetri.

Tehnika: CT abdomena s i.v. kontrastom, portalna venska faza.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U oba režnja jetre, najveća u segmentu [..]: [.. mm] velike, brojne hipodenzne lezije s perifernom imbibicijom kontrastom.

Zaključak: Brojne lezije u jetri koje mogu odgovarati metastazama. U odnosu na prethodnu pretragu [nov/povećan/stabilan]. Preporučuje se klinička i po potrebi patohistološka korelacija.

058 Trauma CT · Ozljeda slezene

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod tupe traume abdomena vidite laceraciju ili hematom slezene. Hitna prijava.

Tehnika: Trauma CT s i.v. kontrastom, arterijska i portalna venska faza.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U slezeni [.. mm] duga laceracija / subkapsularni hematom. Periplenično i [zdjelični] slobodna tekućina (odgovara hemoperitoneumu). Aktivna ekstravazacija kontrasta [nema/ima].

Zaključak: Ozljeda slezene ([laceracija/hematom]) i hemoperitoneum. Znakovi aktivnog krvarenja [nema/ima]. Stupnjevanje se provodi prema sustavu koji se koristi u Vašoj ustanovi. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

059 CT abdomena · Jednostavna cista jetre

Kada se koristi: Slučajne cistične lezije jetre tipičnog izgleda.

Tehnika: CT abdomena s i.v. kontrastom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Segment jetre [..]: [.. mm] velika, oštro ograničena lezija denziteta tekućine, tanke stijenke, bez imbibicije kontrastom.

Zaključak: Segment jetre [..]: lezija koja odgovara jednostavnoj cisti.

060 CT abdomena · Akutni kolecistitis

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u desnom gornjem kvadrantu na CT-u vidite upalu žučnjaka.

Tehnika: CT abdomena s i.v. kontrastom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Žučnjak je distendiran, stijenka zadebljana; perikolecistična tekućina i zamućenje masnog tkiva. U lumenu [konkrement se razlučuje/konkrement se ne razlučuje]. Plin u stijenci, gubitak imbibiranja kontrastom ili perforacija [nema/ima].

Zaključak: Nalazi koji upućuju na akutni kolecistitis. Osjetljivost CT-a za žučne kamence je ograničena; preporučuje se korelacija s UZV-om.

061 CT kralježnice · Akutna fraktura kralješka

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u leđima ili križima nakon traume vidite frakturu trupa kralješka.

Tehnika: Bez kontrasta [torakolumbalni] CT; sagitalne i koronalne rekonstrukcije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [L1] u trupu kralješka [kompresijski/rasprsnuti] prijelom; gubitak prednje visine. Stražnji zid [očuvan/suženje spinalnog kanala retropulziranim fragmentom]. Stražnji elementi [intaktan/prelomljen].

Zaključak: [L1] kralješku akutnog izgleda [kompresijski/rasprsnuti] prijelom; u spinalnom kanalu [suženje prisutno/nije prisutno]. U slučaju neurološkog nalaza preporučuje se MR.

062 CT paranazalnih sinusa · Sinusitis

Kada se koristi: CT pretrage sinusa učinjene zbog kroničnog ili recidivirajućeg sinusitisa.

Tehnika: CT paranazalnih sinusa bez kontrasta; koronalne rekonstrukcije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo/Obostrano] [maksilarni/etmoidni/frontalni/sfenoidni] u sinusu [zadebljanje sluznice/razina zrak-tekućina/potpuna ispunjenost]. Osteomeatalni kompleks [otvoren/zatvoren]. Nije prikazana destrukcija kosti ni širenje u orbitu ili intrakranijski.

Zaključak: [Lokalizacija] nalazi koji odgovaraju sinusitisu. Razina zrak-tekućina može odgovarati akutnom sinusitisu; preporučuje se klinička korelacija.

063 CT abdomena · Incidentalni nodul nadbubrežne žlijezde

Kada se koristi: Slučajevi u kojima na CT-u učinjenom iz drugog razloga vidite slučajni nodul nadbubrežne žlijezde.

Tehnika: [Bez kontrasta/S IV kontrastom] CT abdomena.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u nadbubrežnoj žlijezdi [.. mm] velik, oštro ograničen nodul; [nativni denzitet .. HU/u kontrastnoj pretrazi karakterizacija nije moguća].

Zaključak: [Desno/Lijevo] nodul nadbubrežne žlijezde. Potrebu za karakterizacijom i praćenjem treba odrediti zajedno s kliničkim timom prema važećim smjernicama; po potrebi se preporučuje CT po adrenalnom protokolu ili MR s kemijskim pomakom.

064 CT prsnog koša · Pneumonija (konsolidacija)

Kada se koristi: CT pretrage učinjene kod pneumonija koje nisu jasne na snimci ili kod sumnje na komplikacije.

Tehnika: [Bez kontrasta/S IV kontrastom] CT prsnog koša.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [režanj]: konsolidacija sa zračnim bronhogramom; oko nje zasjenjenja tipa mliječnog stakla. Pleuralni izljev [nema/ima]. U medijastinumu [reaktivnog izgleda] limfni čvorovi. Kavitacija ili apsces [nema/ima].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [režanj] konsolidacija; može odgovarati infektivnom procesu (pneumoniji). Kontrola nakon terapije preporučuje se prema kliničkoj odluci.

065 Trauma CT · Hemoperitoneum

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod tupe traume abdomena vidite slobodnu tekućinu.

Tehnika: Trauma CT s i.v. kontrastom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Morisonov prostor/periplenični prostor/zdjelica]: slobodna tekućina; denzitet [.. HU], što odgovara hemoperitoneumu. Ozljeda parenhimskih organa [nije prikazan/...]. U stijenci crijeva i mezenteriju [nije prikazana patologija/...].

Zaključak: [Mala/Umjerena/Velika] količina hemoperitoneuma. Ako se ozljeda solidnih organa ne prikaže, preporučuje se kliničko praćenje radi moguće ozljede crijeva ili mezenterija. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

POGLAVLJE 3

MR

25 predložaka: 3 normalna, 22 česta nalaza u rutini i na dežurstvu.

066 MR mozga · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: MR pretrage mozga bez patologije pri obradi glavobolje, vrtoglavice ili napadaja.

Tehnika: MR mozga; aksijalne T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI/T2*], [postkontrastni T1] sekvencije.
Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.
Nalaz: U moždanom parenhimu nije utvrđena abnormalnost signala. Na DWI nema restrikcije difuzije. Ventrikularni sustav i sulkusi odgovaraju dobi. Strukture središnje linije su uredne.
[Nakon kontrasta nema patološke imbibicije.] U glavnim arterijama prikazuju se praznine protoka (flow voids).

Zaključak: Na MR-u mozga nije utvrđena značajna patologija.

067 MR lumbalne kralježnice · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Slučajevi križobolje u kojima ne vidite patologiju diska, korijena ili kanala.

Tehnika: MR lumbalne kralježnice; sagitalne T1, T2, STIR i aksijalne T2 sekvencije.
Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.
Nalaz: Lumbalna lordoza je očuvana, poravnanje kralježaka je normalno. Visine trupova kralježaka i signal koštane srži su uredni. Na intervertebralnim diskovima nisu prikazani izražena degeneracija ni hernijacija. Spinalni kanal i neuralni foramini su prohodni. Konus medularis je normalne razine i signala.

Zaključak: Na MR-u lumbalne kralježnice nije utvrđena značajna patologija.

068 MR koljena · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Slučajevi boli ili ozljede koljena u kojima ne vidite strukturnu patologiju.

Tehnika: [Desno/Lijevo] MR koljena; PD sekvencije sa supresijom masti, T1 i T2 sekvencije, tri ravnine.
Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.
Nalaz: U meniscima nije prikazano pojačanje signala koje bi upućivalo na rupturu. Prednja i stražnja ukrižena sveza, kolateralne sveze i ekstenzorni mehanizam su uredni. Nema edema koštane srži. Zglobna hrskavica je očuvana. Nema izraženog zglobnog izljeva.

Zaključak: [Desno/Lijevo] koljeno: na MR-u nije utvrđena značajna patologija.

069 MR mozga · Akutni infarkt (DWI)

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod akutnog žarišnog deficita vidite restrikciju difuzije. Prijava.

Tehnika: MR mozga; sekvencije DWI/ADC, FLAIR, T2, SWI/T2*.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [regija]: područje hiperintenzivno na DWI, hipointenzivno na ADC mapi, s restrikcijom difuzije. Na FLAIR-u [bez izraženih promjena signala/blaga hiperintenzivnost]. Hemoragijska transformacija [nije prikazan/prikazan je].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [arterija] područje opskrbe: akutni infarkt. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

070 MR mozga · Demijelinizacijski plakovi

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod optičkog neuritisa, osjetnog deficita ili praćenja MS-a vidite lezije bijele tvari.

Tehnika: MR mozga; FLAIR (prednost ima 3D), T2, T1, DWI, T1 nakon kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Periventrikularno, [jukstakortikalno], [infratentorijalno] smještene, ovoidne T2/FLAIR hiperintenzivne lezije orijentirane okomito na korpus kalozum. Nakon kontrasta [.. imbibicija lezije kontrastom/bez imbibicije kontrastom].

Zaključak: Lezije bijele tvari koje mogu odgovarati demijelinizacijskoj bolesti. Nova ili imbibirana lezija u odnosu na prethodnu pretragu [nema/ima]. Dijagnozu treba procijeniti zajedno s kliničkim nalazima i važećim dijagnostičkim kriterijima.

071 MR mozga · Prstenasto imbibirana intraaksijalna masa

Kada se koristi: Parenhimske lezije koje se imbibiraju kontrastom, s učinkom mase i edemom.

Tehnika: MR mozga s kontrastom; DWI, [perfuzija], SWI sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [režanj]: [.. mm] velika masa s nepravilnom prstenastom imbibicijom kontrastom i centralnom nekrozom; oko nje vazogeni edem i učinak mase. Širenje na korpus kalozum [nema/ima]. Izrazita restrikcija difuzije u središnjem dijelu [nema/ima].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [režanj] intraaksijalna masa s prstenastom imbibicijom kontrastom; u diferencijalnoj dijagnozi prvenstveno se razmatraju glijalni tumor visokog stupnja i metastaza. Ako postoji izražena centralna restrikcija difuzije, u diferencijalnu dijagnozu treba uključiti apsces.

072 MR mozga · Meningeom

Kada se koristi: Ekstraaksijalne mase sa širokom duralnom bazom i homogenim imbibiranjem.

Tehnika: MR mozga s kontrastom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Regija]: s duralnom bazom, [.. mm] velika ekstraaksijalna masa, na T1 izointenzivna, s homogenom imbibicijom kontrastom; znak duralnog repa. Edem u susjednom parenhimu [nema/ima]. Učinak mase [nema/ima].

Zaključak: [Regija]: ekstraaksijalna masa koja odgovara meningeomu.

073 MR hipofize · Adenom hipofize

Kada se koristi: MR pretrage hipofize učinjene zbog hormonskog poremećaja ili ispada vidnog polja.

Tehnika: MR hipofize; koronalne i sagitalne T1 i T2 tankih slojeva, dinamičke serije s kontrastom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U hipofizi [.. mm] velika lezija koja se u dinamičkim serijama imbibira kontrastom kasnije od normalne žlijezde. Supraselarno širenje [nema/ima]; kompresija optičke kijazme [nema/ima]. Invazija kavernoznog sinusa [suspektno/nije prisutno]. Peteljka hipofize [u središnjoj liniji/devijiran].

Zaključak: Hipofiza [mikro/makro] lezija koja odgovara adenomu. Preporučuje se endokrinološka korelacija.

074 MR mozga · Apsces mozga

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod vrućice i žarišnog deficita vidite glatko ograničenu, prstenasto imbibiranu leziju. Prijava.

Tehnika: MR mozga s kontrastom; uključujući DWI/ADC.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Lokalizacija]: [.. mm] velika lezija s tankom i pravilnom prstenastom imbibicijom kontrastom; sadržaj pokazuje izraženu restrikciju difuzije na DWI. Okolni vazogeni edem.

Zaključak: Nalazi koji odgovaraju apscesu mozga. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

075 MR mozga i MR venografija · Tromboza venskih sinusa

Kada se koristi: Bolesnici s glavoboljom, napadajem ili edemom papile, osobito oni s čimbenicima rizika. Prijava.

Tehnika: MR mozga i MR venografija s kontrastom i bez kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Gornji sagitalni/transverzalni/sigmoidni] u sinusu gubitak normalne praznine protoka i signal koji odgovara trombu; na MR venografiji defekt punjenja/gubitak protoka. U susjednom parenhimu venski infarkt ili krvarenje [nema/ima].

Zaključak: [Sinus] tromboza. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

076 MR mozga · Kronična bolest malih krvnih žila

Kada se koristi: Nespecifične lezije bijele tvari kod starijih bolesnika ili onih s vaskularnim čimbenicima rizika.

Tehnika: MR mozga; sekvencije FLAIR, T2, DWI.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Obostrano u periventrikularnoj i dubokoj bijeloj tvari točkaste, mjestimično konfluirajuće T2/FLAIR hiperintenzivnosti. Na DWI nema restrikcije difuzije. [Kronični lakunarni infarkti.]

Zaključak: Promjene bijele tvari koje mogu odgovarati kroničnoj bolesti malih krvnih žila. Akutni infarkt nije utvrđen.

077 MR lumbalne kralježnice · Hernija diska

Kada se koristi: MR pretrage lumbalne kralježnice zbog boli u križima i nozi (radikulopatija).

Tehnika: MR lumbalne kralježnice; sagitalne T1, T2 i aksijalne T2 sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: L [4-5] u disku gubitak T2 signala i smanjenje visine; [desno/lijevo] [paramedijalno/foraminalno] [protruzija/ekstruzija] tip hernijacije. [Desno/Lijevo] [L5] u korijenu živca [kontakt/kompresija]. Spinalni kanal [prohodan/sužen]. Neuralni foramini [prohodan/sužen].

Zaključak: L [4-5] [desno paramedijalno] disk [ekstruzija]; [L5] na korijen živca [kompresija].

078 MR vratne kralježnice · Kompleks disk-osteofit

Kada se koristi: MR pretrage vratne kralježnice zbog boli u vratu i ruci ili utrnulosti.

Tehnika: MR vratne kralježnice; sagitalne T1, T2, STIR i aksijalne T2 sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: C [5-6] na toj razini [desno/lijevo] [paramedijalno/foraminalno] kompleks disk-osteofit; [desno/lijevo] suženje neuralnog foramena. Signal kralježnične moždine [uobičajen/T2 hiperintenzivan].

Zaključak: C [5-6] kompleks disk-osteofit i [desno] foraminalno suženje. Promjena signala moždine [nije prisutan/prisutan; može odgovarati mijelopatiji].

079 MR torakalne kralježnice · Epiduralna kompresija i kompresija kralježnične moždine

Kada se koristi: Bol u leđima ili novi neurološki deficit kod bolesnika s poznatom malignom bolešću. Hitna prijava.

Tehnika: Torakalni s kontrastom [i cijele kralježnice] MR.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: T [..] kralješku T1 hipointenzivna lezija koštane srži koja se imbibira kontrastom; epiduralnim širenjem suženje spinalnog kanala i kompresija kralježnične moždine. T2 pojačanje signala u moždini [nema/ima]. Na ostalim razinama [bez dodatnih lezija/dodatne lezije].

Zaključak: T [..] u razini lezija koja može odgovarati epiduralnom širenju tumora i kompresija kralježnične moždine. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

080 MR lumbalne kralježnice · Akutna kompresijska fraktura

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod manje traume ili križobolje bez traume vidite gubitak visine trupa kralješka.

Tehnika: MR lumbalne kralježnice; sagitalne T1, T2, STIR sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [L1] gubitak visine trupa kralješka; na STIR-u edem koštane srži. Retropulzija stražnjeg zida [nema/ima]. Zahvaćenost stražnjih elemenata, epiduralna ili paravertebralna mekotkivna masa [nije prikazan/prikazan je].

Zaključak: [L1] kralježak: [akutni/subakutni] kompresijski prijelom. Nalazi u prilog patološkog prijeloma [nije prikazan/prikazan je; preporučuje se daljnja obrada].

081 MR koljena · Ruptura prednje ukrižene sveze

Kada se koristi: Slučajevi koji nakon rotacijske ozljede dolaze s nestabilnošću i izljevom.

Tehnika: [Desno/Lijevo] MR koljena; PD sekvencije sa supresijom masti i T1 sekvencije, tri ravnine.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U ACL-u [proksimalni/srednji dio] gubitak kontinuiteta i normalnog linearnog izgleda. Kontuzija kosti lateralnog femoralnog kondila i posterolateralnog tibijalnog platoa [prisutan/odsutan]. Zglobni izljev.

Zaključak: [Puna debljina/Parcijalna] Ruptura ACL-a. Prateća [meniskus/kolateralni ligament] patologija [nema/ima].

082 MR koljena · Ruptura meniska

Kada se koristi: MR pretrage koljena učinjene zbog blokade, boli u zglobnoj pukotini ili nakon traume.

Tehnika: [Desno/Lijevo] MR koljena; PD sekvencije sa supresijom masti.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Medijalno/Lateralno] meniskus [stražnji rog/tijelo/prednji rog] u dijelu, koja se proteže do zglobne površine [horizontalna/kosa/radijalna/longitudinalna] pojačanje signala.
[Dislocirani fragment meniskusa (ručka kante) nije prikazan/prikazan je.]

Zaključak: [Medijalno] meniskus [stražnji rog] [kosa] ruptura.

083 MR koljena · Kontuzija kosti

Kada se koristi: Slučajevi u kojima je nakon traume snimka normalna, a na MR-u vidite edem koštane srži.

Tehnika: [Desno/Lijevo] MR koljena; PD sekvencije sa supresijom masti i T1 sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Lateralni femoralni kondil/tibijalni plato]: bez jasne linije prijeloma edem koštane srži na sekvencijama sa supresijom masti. Na T1 linearna hipointenzivna linija prijeloma [nema/ima].

Zaključak: [Regija]: kontuzija kosti;
[linija prijeloma nije prikazana/prikazana je subhondralna linija prijeloma].

084 MR ramena · Ruptura rotatorne manšete

Kada se koristi: MR pretrage ramena učinjene zbog boli u ramenu i slabosti abdukcije.

Tehnika: [Desno/Lijevo] MR ramena; PD/T2 sekvencije sa supresijom masti i T1 sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Tetive m. supraspinatus [anteriorno] u dijelu
[artikularna strana/burzalna strana, parcijalna debljina/puna debljina] ruptura; retrakcija [.. mm]. Atrofija ili masna infiltracija mišića [nema/ima]. Tekućina u subakromijalno-subdeltoidnoj burzi.

Zaključak: U tetivi m. supraspinatusa [puna debljina/parcijalna debljina] ruptura; retrakcija [.. mm].

085 MR kuka · Avaskularna nekroza glave femura

Kada se koristi: Bolesnici s boli u kuku koji uzimaju steroide ili imaju čimbenike rizika.

Tehnika: MR obaju kukova; koronalne T1, STIR i aksijalne sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u glavi femura subhondralno područje nalik zemljopisnoj karti, okruženo T1 hipointenzivnom linijom; na T2 znak dvostruke linije. Kolaps zglobne površine [nema/ima]. Zglobni izljev [nema/ima]. Kontralateralna glava femura [uobičajen/slična promjena].

Zaključak: [Desno/Lijevo] avaskularna nekroza glave femura; kolaps zglobne plohe [nije prikazan/prikazan je].

086 MR jetre · Hemangiom

Kada se koristi: Karakterizacija lezije jetre koja je ostala nejasna na UZV-u ili CT-u.

Tehnika: Dinamički MR jetre s kontrastom; T2, DWI te arterijska, portalna venska i odgođena faza.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Segment jetre [..]: [.. mm], lezija izrazito hiperintenzivna na T2, koja u dinamičkim serijama pokazuje periferno nodularno i centripetalno progresivno imbibiranje kontrastom.

Zaključak: Segment jetre [..]: lezija koja odgovara tipičnom hemangiomu.

087 MRCP · Koledokolitijaza

Kada se koristi: Procjena žučnih vodova kod bolesnika sa znakovima kolestaze ili žučnim kamencima.

Tehnika: MRCP; jako T2 mjerene 2D i 3D sekvencije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U distalnom koledokusu [.. mm] velik defekt punjenja koji na T2 stvara prazninu signala. Koledokus [.. mm] promjera, u intrahepatalnim žučnim vodovima [blaga] dilatacija. U žučnom mjehuru [konkrementi].

Zaključak: Kamenac u distalnom koledokusu (koledokolitijaza) i dilatacija žučnih vodova. Ako postoji klinička sumnja na kolangitis, kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

088 MR lumbalne kralježnice · Spondilodiscitis

Kada se koristi: MR pretrage s kontrastom učinjene zbog vrućice, povišenih upalnih biljega i križobolje.

Tehnika: MR lumbalne kralježnice s kontrastom; T1, T2, STIR i T1 sa supresijom masti nakon kontrasta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: L[..] u disku T2 hiperintenzivnost i imbibicija kontrastom; erozija susjednih pokrovnih ploča i edem koštane srži. [Paravertebralno/epiduralno] [flegmona/apsces] [nema/ima].

Zaključak: L[..] nalazi koji odgovaraju spondilodiscitisu; epiduralni apsces [nema/ima]. U slučaju epiduralnog apscesa kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

089 MR koljena · Poplitealna (Bakerova) cista

Kada se koristi: Bolesnici s oteklinom ili boli u zakoljenu.

Tehnika: [Desno/Lijevo] MR koljena.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U poplitealnoj jami, koja se pruža između tetiva medijalne glave m. gastrocnemius i m. semimembranosus [.. mm] kolekcija tekućine. Okolni edem u prilog rupture [nema/ima].

Zaključak: Poplitealna (Bakerova) cista; znakovi rupture [nema/ima].

090 MR zdjelice · Jednostavna adneksalna cista

Kada se koristi: Karakterizacija adneksalne cistične lezije otkrivene UZV-om.

Tehnika: MR zdjelice s kontrastom; T1, T1 sa supresijom masti, T2, DWI.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u jajniku [.. mm] velika tankostijena, pravilno ograničena cistična lezija, na T2 homogeno hiperintenzivna, bez solidne komponente ili septa koje se imbibiraju kontrastom.

Zaključak: [Desno/Lijevo] lezija u jajniku koja odgovara jednostavnoj cisti. Potrebu za praćenjem treba odrediti klinički tim prema dobi pacijentice i menopauzalnom statusu.

POGLAVLJE 4

UZV i dopler

30 predložaka: 5 normalnih, 25 čestih nalaza na dežurstvu i u rutini (uključujući POCUS i eFAST).

091 UZV cijelog abdomena · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: UZV pregledi abdomena kod boli u trbuhu ili rutinske kontrole na kojima ne vidite patologiju.

Tehnika: UZV cijelog abdomena; [natašte].

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Jetra normalne veličine i ehogenosti, bez prikazane žarišne lezije. Žučnjak uredne stijenke, lumen anehogen; kamenci nisu prikazani. Intrahepatalni i ekstrahepatalni žučni vodovi nisu dilatirani. Gušterača [prikazani dijelovi] uredan. Slezena normalne veličine. Oba bubrega normalne veličine i ehogenosti parenhima; pijelokalikalni sustav nije dilatiran. Mokraćni mjehur [ispunjen, prirodne stijenke]. U abdomenu nije prikazana slobodna tekućina.

Zaključak: Na UZV-u cijelog abdomena patologija nije utvrđena.

092 UZV mokraćnog sustava · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u slabini, infekcije mokraćnog sustava ili poremećaja bubrežne funkcije ne vidite patologiju.

Tehnika: UZV mokraćnog sustava.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Oba bubrega normalne veličine, položaja i debljine parenhima; kortikomedularna diferencijacija je očuvana. Kanalni sustav nije dilatiran. Nisu prikazani kamenci ni masa. Mokraćni mjehur [ispunjen, prirodne stijenke, anehogenog lumena].

Zaključak: Na UZV-u mokraćnog sustava patologija nije utvrđena.

093 UZV štitnjače · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod pitanja o poremećaju funkcije štitnjače ili palpabilnoj oteklini ne vidite patologiju.

Tehnika: UZV štitnjače i vrata; visokofrekventna linearna sonda.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Štitnjača je normalne veličine i homogene ehogenosti parenhima. Nisu prikazani noduli. Vaskularizacija na obojenom dopleru je uredna. Na vratu nisu utvrđeni limfni čvorovi patološkog izgleda.

Zaključak: Na UZV-u štitnjače patologija nije utvrđena.

094 Venski dopler donjih ekstremiteta · Normalan nalaz

NORMALNO

Kada se koristi: Venski dopler pregledi kod sumnje na DVT u kojima ne vidite trombozu.

Tehnika: [Desno/Lijevo] Doppler UZV vena donjih ekstremiteta; kompresija u sivoj skali, obojeni i spektralni Doppler.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Zajednička femoralna, femoralna i poplitealna vena potpuno su kompresibilne; u lumenu nije prikazan tromb. Na obojenom dopleru punjenje lumena je potpuno, a na spektralnoj analizi prisutna je respiracijska varijabilnost i odgovor na augmentaciju. [Vene potkoljenice uključene su u procjenu/nisu uključene u procjenu].

Zaključak: [Desno/Lijevo] donji ekstremitet [u dubokim venama] tromboza nije utvrđena.

095 eFAST · Negativan

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod traumatiziranog bolesnika na eFAST-u uz krevet ne vidite slobodnu tekućinu ni pneumotoraks.

Tehnika: eFAST uz krevet.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U Morisonovu prostoru, splenorenalnom području i zdjelici nije prikazana slobodna tekućina. Na subksifoidnom prikazu nema perikardijalnog izljeva. Obostrano je prikazano klizanje pluća (lung sliding).

Zaključak: eFAST-om nisu utvrđeni nalazi u prilog slobodne tekućine, perikardijalnog izljeva ili pneumotoraksa. Negativan eFAST ne isključuje ozljedu organa; ovisno o kliničkom stanju preporučuje se CT.

096 UZV abdomena · Kolelitijaza

Kada se koristi: Slučajevi u kojima u žučnjaku vidite ehogeno žarište s akustičnom sjenom.

Tehnika: UZV abdomena; natašte.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U lumenu žučnjaka, najveći [.. mm] veliki ehogeni fokusi s posteriornom akustičnom sjenom, pomični s promjenom položaja. Debljina stijenke [uobičajen/povećan]. Perikolecistična tekućina [nema/ima]. Sonografski Murphyjev znak [negativan/pozitivan]. Koledokus [.. mm].

Zaključak: Kolelitijaza. Nalaz koji upućuje na akutni kolecistitis [nije prikazan/prikazan je].

097 UZV abdomena · Akutni kolecistitis

Kada se koristi: Slučajevi s boli u desnom gornjem kvadrantu, vrućicom i sonografskim Murphyjevim znakom.

Tehnika: UZV abdomena.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Žučnjak je distendiran, stijenka zadebljana [i edematozna, dvostruka kontura]; u vratnom dijelu [.. mm] konkrement. Perikolecistična tekućina [prisutan]. Sonografski Murphyjev znak je pozitivan.

Zaključak: Nalazi koji odgovaraju akutnom kalkuloznom kolecistitisu. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

098 UZV mokraćnog sustava · Hidronefroza

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u slabini, bubrežnih kolika ili poremećaja bubrežne funkcije vidite dilataciju kanalnog sustava.

Tehnika: UZV mokraćnog sustava.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u bubregu [blago/umjereno/izraženo] pijelokalikalna dilatacija; proksimalni ureter [dilatiran/nije prikazan]. Debljina parenhima [očuvan/stanjen]. Kao uzrok opstrukcije [konkrement od .. mm na ureterovezikalnom spoju/jasan uzrok nije prikazan]. Mokraćni mjehur [..].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [blago/umjereno/izraženo] hidronefroza; [mogući uzrok]. Ako uzrok nije jasan, preporučuje se korelacija s CT-om bez kontrasta.

099 FAST · Slobodna tekućina u Morisonovu prostoru

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod traumatiziranog bolesnika na FAST-u vidite slobodnu tekućinu. Hitna prijava.

Tehnika: FAST uz krevet.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U Morisonovu prostoru [i u splenorenalnom prostoru/u zdjelici] anehogena slobodna tekućina. Perikardijalni izljev [nema/ima].

Zaključak: FAST pozitivan: [U Morisonovu džepu] slobodna tekućina. Ovisno o hemodinamskom stanju hitna klinička procjena; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

100 UZV prsnog koša · Pleuralni izljev

Kada se koristi: Sumnja na izljev na snimci ili određivanje količine i položaja prije torakocenteze.

Tehnika: UZV prsnog koša; [u sjedećem položaju], interkostalni pregled.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo/Obostrano] u pleuralnom prostoru [anehogen/s ehogenim sadržajem/septiran] tekućina; na najdubljem mjestu [.. mm]. Kompresivna atelektaza u susjednom plućnom parenhimu. [Pleuralna nodularnost nije prikazana.]

Zaključak: [Desno/Lijevo] [anehogen/kompliciranog izgleda] pleuralni izljev. [Označen je prikladan prozor za torakocentezu.]

101 UZV pluća · B-linije

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod bolesnika s dispnejom na UZV-u pluća uz krevet vidite B-linije.

Tehnika: UZV pluća uz krevet; obostrani pregled po regijama.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Obostrano [anteriorno i lateralno] područjima, u svakom polju brojne B-linije. Pleuralna linija [pravilan/nepravilan i zadebljan]. Pleuralni izljev [nema/ima].

Zaključak: Obostrano brojne B-linije; odgovara intersticijskom sindromu. Uz glatku pleuralnu liniju može upućivati na kardiogeni plućni edem; preporučuje se klinička i ehokardiografska korelacija.

102 Venski dopler · Duboka venska tromboza

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod bolesnika s oteklinom i boli u nozi vidite venu koja se ne komprimira. Prijava.

Tehnika: [Desno/Lijevo] Doppler UZV vena donjih ekstremiteta.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Zajednička femoralna/femoralna/poplitealna] veni koja se ne komprimira, lumen [djelomično/potpuno] ispunjen ehogenim trombom; na obojenom Doppleru [bez protoka/parcijalni protok]. Tromb [proksimalna granica: ..].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [femoropoplitealna] segmentu nalazi koji odgovaraju akutnoj dubokoj venskoj trombozi. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

103 UZV desnog donjeg kvadranta · Akutni apendicitis

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod djeteta, mladog pacijenta ili trudnice s bolovima u donjem desnom kvadrantu vidite upaljeni apendiks.

Tehnika: UZV desnog donjeg kvadranta; tehnika postupne kompresije.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U desnom donjem kvadrantu, nekompresibilan, [.. mm] promjera, slijepo završavajuća tubularna struktura (apendiks); na obojenom Doppleru pojačana vaskularizacija stijenke. Pojačana ehogenost okolnog masnog tkiva. Apendikolit [prisutan/odsutan]. Periapendikularna tekućina [nema/ima].

Zaključak: Nalazi koji odgovaraju akutnom apendicitisu. Kliničkom timu [vrijeme] javljeno. / Apendiks nije prikazan; to ne isključuje apendicitis.

104 UZV abdominalne aorte · Aneurizma

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod probira, pulsirajuće mase ili boli u trbuhu i leđima vidite proširenje aorte.

Tehnika: UZV abdominalne aorte; transverzalna i longitudinalna mjerenja.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U infrarenalnoj abdominalnoj aorti maksimalni [.. mm] promjera, aneurizmatsko proširenje; u lumenu [muralni tromb]. Periaortalna tekućina [nije prikazan/prikazan je].

Zaključak: Infrarenalna aneurizma abdominalne aorte, maksimalni promjer [.. mm]. Kod simptomatskog bolesnika ruptura se ne može isključiti UZV-om; kliničkom timu [vrijeme] javljeno i preporučuje se CT angiografija.

105 UZV štitnjače · Nodul štitnjače

Kada se koristi: Palpabilni nodul ili slučajno otkriven nodul štitnjače.

Tehnika: UZV štitnjače; linearna sonda, obojeni dopler.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Štitnjača [desno/lijevo] režanj [gornji/srednji/donji] u dijelu [.. x .. x .. mm] veličine, [solidna/cistična/miješana], [hipoehogen/izoehogen/hiperehogen], [pravilan/nepravilan] ograničen nodul. Mikrokalcifikacije [nema/ima]. [Vertikalna orijentacija duge osi nije prisutna/prisutna je]. Patološki limfni čvor na vratu [nema/ima].

Zaključak: Štitnjača [desni režanj]: [.. mm] nodul; prema klasifikaciji rizika koju koristi Vaša ustanova [kategorija]. Potreba za aspiracijskom biopsijom tankom iglom i praćenjem treba se odrediti prema ovoj klasifikaciji.

106 UZV abdomena · Steatoza jetre

Kada se koristi: Slučajevi u kojima vidite difuzno povećanu ehogenost parenhima jetre.

Tehnika: UZV abdomena.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Jetra [normalne veličine/povećan]; ehogenost parenhima difuzno povećana u odnosu na koru bubrega; stijenke portalne vene i ošit [razlučiv/nije razlučiv]. Nije prikazana žarišna lezija.

Zaključak: [Blaga/Umjerena/Izražena] izgled koji odgovara steatozi jetre.

107 UZV zdjelice · Sumnja na izvanmaterničnu trudnoću

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod bolesnice s pozitivnim testom na trudnoću nije prikazana intrauterina trudnoća. Prijava.

Tehnika: Transabdominalni [i transvaginalni] UZV zdjelice.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U šupljini maternice nije prikazana gestacijska vreća. [Desno/Lijevo] u adneksalnom području, odvojeno od jajnika [.. mm] heterogena masa [/u kojoj je žumanjčana vreća ili embrij]. U Douglasovu prostoru [s ehogenim sadržajem] slobodna tekućina [prisutan/odsutan].

Zaključak: Intrauterina trudnoća nije prikazana; [desno/lijevo] adneksalna tvorba i [slobodna tekućina] uz nalaze u prilog ektopične trudnoće. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

108 Ehokardiografski prozor / POCUS · Perikardijalni izljev

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod dispneje, hipotenzije ili traume na subksifoidnom prikazu vidite perikardijalnu tekućinu.

Tehnika: Subksifoidni uz krevet [i parasternalno] snimanje.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U perikardijalnom prostoru [cirkumferentno/lokalizirano] anehogena tekućina; na najširem mjestu [.. mm]. Dijastolički kolaps desnog atrija/desnog ventrikula [nije prikazan/prikazan je].

Zaključak: [Mala/Umjerena/Velika] perikardijalni izljev. Nalazi u prilog tamponade [nije prisutan/prisutan; prijavljeno kao hitni nalaz]. Za detaljnu procjenu preporučuje se ehokardiografija.

109 UZV mokraćnog sustava · Jednostavna cista bubrega

Kada se koristi: Slučajne, anehogene lezije bubrega.

Tehnika: UZV mokraćnog sustava.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] bubreg [gornji/srednji/donji] u polu [.. mm] velika tankostijena anehogena cista s posteriornim akustičnim pojačanjem, bez septa ili solidne komponente.

Zaključak: [Desno/Lijevo] lezija u bubregu koja odgovara jednostavnoj kortikalnoj cisti.

110 UZV abdomena · Apsces jetre

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod vrućice i boli u desnom gornjem kvadrantu vidite kompliciranu cističnu leziju u jetri.

Tehnika: UZV abdomena; obojeni dopler.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Segment jetre [..]: [.. mm] velika, nepravilne stijenke, s unutarnjim odjecima i [detritus] hipoehogena/kompleksna cistična lezija; oko nje [hiperemija].

Zaključak: Segment jetre [..]: lezija koja može odgovarati apscesu. Preporučuje se klinička i laboratorijska korelacija; po potrebi CT s kontrastom. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

111 Dopler UZV skrotuma · Sumnja na torziju testisa

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod naglo nastale skrotalne boli vidite smanjen protok u zahvaćenom testisu. Hitna prijava.

Tehnika: UZV skrotuma u sivoj skali i obojeni/spektralni dopler; usporedno s kontralateralnim testisom.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] testis [povećan, heterogen]; intratestikularni protok na obojenom dopleru [nije prikazan/izrazito smanjen u odnosu na suprotnu stranu]. U sjemenom tračku [znak vrtloga]. Kontralateralni testis je uredan.

Zaključak: [Desno/Lijevo] nalazi koji odgovaraju torziji testisa. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme] javljeno. Prisutnost protoka ne isključuje u potpunosti torziju.

112 UZV abdomena · Ascites

Kada se koristi: Procjena tekućine kod nadutosti trbuha ili prije paracenteze.

Tehnika: UZV abdomena.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: U abdomenu, u perihepatalnom, perisplenalnom i zdjeličnom području [mala/umjerena/velika] količina [anehogen/s ehogenim sadržajem/septiran] slobodna tekućina. Kontura jetre [gladak/nodularan].

Zaključak: [Mala/Umjerena/Velika] količina ascitesa. [Označen je prikladan prozor za paracentezu.]

113 UZV dojke · Jednostavna cista

Kada se koristi: UZV procjena palpabilne mase ili lezije otkrivene mamografijom.

Tehnika: Obostrani UZV dojki; linearna sonda.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] u dojci, na satnom položaju [..] u razini, od bradavice [.. cm] udaljenosti, [.. mm] velika ovalna, oštro ograničena anehogena lezija s posteriornim akustičnim pojačanjem.

Zaključak: [Desno/Lijevo] lezija u dojci koja odgovara jednostavnoj cisti; prema klasifikaciji koju koristi Vaša ustanova [kategorija].

114 Dopler UZV karotida · Aterosklerotski plak

Kada se koristi: Procjena karotida kod moždanog udara, tranzitorne ishemijske atake ili probira vaskularnog rizika.

Tehnika: Obostrani dopler UZV karotidnih i vertebralnih arterija.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] [zajednička karotida/bulbus/unutarnja karotida] u arteriji [kalcificiran/hipoehogen/heterogen] aterosklerotski plak. Vršna sistolička brzina protoka u razini plaka [.. cm/s]. Protok u vertebralnim arterijama [antegradni].

Zaključak: [Desno/Lijevo] [unutarnja karotidna] aterosklerotski plak u arteriji; stupanj stenoze prema Doppler kriterijima koje koristi Vaša ustanova [stupanj]. Kod značajne stenoze preporučuje se korelacija s CT ili MR angiografijom.

115 UZV abdomena · Dilatacija koledokusa

Kada se koristi: Slučajevi s povišenim kolestatskim enzimima ili žuticom i proširenim žučnim vodovima.

Tehnika: UZV abdomena.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: Koledokus [.. mm] promjera, dilatiran; intrahepatalni žučni vodovi [dilatiran/nije dilatiran]. U distalnom koledokusu [.. mm konkrement/uzrok opstrukcije nije moguće razlučiti; distalni segment nije prikazan zbog crijevnog plina]. U žučnjaku [konkrement prisutan/nije prisutan].

Zaključak: Dilatacija koledokusa; [mogući uzrok]. Ako uzrok nije utvrđen, preporučuje se MRCP.

116 UZV mokraćnog sustava · Konkrement u bubregu

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli u slabini ili hematurije u bubregu vidite žarište s akustičnom sjenom.

Tehnika: UZV mokraćnog sustava.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] bubreg [donji/srednji/gornji] u čašici pola [.. mm] velik ehogeni fokus s akustičnom sjenom (artefakt svjetlucanja na obojenom Dopleru [prisutan]). Kanalni sustav [nije dilatiran/dilatiran].

Zaključak: [Desno/Lijevo] u bubregu [.. mm] konkrement; [bez hidronefroze/uz prateću hidronefrozu].

117 POCUS pluća · Znakovi pneumotoraksa

Kada se koristi: Slučajevi u kojima nakon traume ili intervencije na UZV-u pluća uz krevet nije prikazano klizanje pluća. Hitna prijava.

Tehnika: UZV pluća uz krevet; prednja stijenka prsnog koša, M-način.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] na prednjoj stijenci prsnog koša nije prikazano klizanje pluća (lung sliding); nema B-linija. U M-modu [znak barkoda/stratosfere]. Plućna točka (lung point) [prikazan/nije prikazan].

Zaključak: [Desno/Lijevo] nalazi u prilog pneumotoraksa ([prikazana je točka pluća]). Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

118 UZV abdomena (dijete) · Invaginacija

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod male djece s intermitentnom boli u trbuhu i povraćanjem vidite znak mete. Hitna prijava.

Tehnika: UZV abdomena; linearna i konveksna sonda.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Gornji desni kvadrant/Desni abdomen], u poprečnom presjeku izgled mete (target), u uzdužnom presjeku izgled pseudobubrega [.. mm] promjera, crijevni segment. Unutar njega [limfni čvor/vodeća točka] [nema/ima]. Protok u stijenci na obojenom dopleru [očuvan/smanjen]. Slobodna tekućina u okolini [nema/ima].

Zaključak: [Ileokolična] invaginacija (podudarni nalazi). Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.

119 Dopler UZV skrotuma · Epididimoorhitis

Kada se koristi: Slučajevi u kojima kod boli i otekline skrotuma vidite hiperemiju epididimisa.

Tehnika: UZV skrotuma u sivoj skali i obojeni dopler.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Desno/Lijevo] epididimis [glava/tijelo] dio povećan i heterogen; na obojenom Doppleru izrazito pojačana vaskularizacija. U testisu [hiperemija prisutna/nije prisutna]. Reaktivna hidrokela [prisutan/odsutan]. Kontralateralni testis i epididimis su uredni.

Zaključak: [Desno/Lijevo] [epididimitis/epididimoorhitis] (podudarni nalazi). Testikularni protok je očuvan.

120 UZV mekih tkiva · Apsces

Kada se koristi: Traženje kolekcije u slučajevima s oteklinom, crvenilom i boli potkožja.

Tehnika: UZV površinskih mekih tkiva; linearna sonda, obojeni dopler.

Usporedba: [datum] – uspoređeno je s prethodnom pretragom od tog datuma. / Nema prethodne pretrage za usporedbu.

Nalaz: [Regija]: u potkožnom masnom tkivu [.. mm] velika, nepravilno ograničena hipoehogena kolekcija s unutarnjim odjecima i sadržajem koji se pomiče na kompresiju; oko nje pojačana vaskularizacija i edem (izgled kaldrme).

Zaključak: [Regija]: kolekcija koja odgovara apscesu mekih tkiva i znakovi okolnog celulitisa.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite Bonus 1 · Banka od 200 zaključaka opisa. Najteži dio predloška je polje Zaključak; rečenicama iz banke za normalne, incidentalne i hitne nalaze zaključite svaki opis jednom jasnom rečenicom.

Prije potpisivanja **Brzi bonus · Kontrolni popis opisa na jednoj stranici** imajte uza sebe.